Correction de soins infirmiers en chirurgie

INFAS Abengourou
Diplôme d’État blanc 2025–2026
Version A • Durée du sujet 1 h 30

55 questions avec propositions, réponses, explications et sources. Pour les QCD : A = Vrai ; B = Faux. Pour les QCM, sélectionner toutes les réponses exactes demandées.

Les pages citées pour les cours correspondent aux pages imprimées. Les références complémentaires sont identifiées par leur organisme et leur rubrique.

Questions à choix doubles

Question 1 — Une appendicite située dans la fosse iliaque gauche peut s’observer en cas de situs inversus.

A. Vrai

B. Faux

Réponse : A — Vrai

Explication : Le situs inversus correspond à une disposition en miroir des organes. Il peut expliquer une appendicite à gauche ; cette localisation peut aussi résulter d’une malrotation intestinale.

Source : INFAS, chirurgie L2 .pdf, Prise en charge infirmière des pathologies chirurgicales, 2024–2025, p. 116, formes topographiques de l’appendicite. Complément : Taslakian et al., BMJ Case Reports, 2013, doi:10.1136/bcr-2013-009474.

Question 2 — La contention dans la fracture des os de la jambe s'effectue avec un plâtre allant du 1/3 inférieur de la cuisse aux orteils.

A. Vrai

B. Faux

Réponse : B — Faux

Explication : Le cours décrit un grand plâtre allant du tiers moyen de la cuisse aux orteils, immobilisant le genou et la cheville. Reformulation : la contention peut utiliser un plâtre cruro-pédieux partant du tiers moyen de la cuisse.

Source : INFAS, chirurgie L2 .pdf, Prise en charge infirmière des pathologies chirurgicales, 2024–2025, p. 56, fractures des deux os de la jambe, traitement orthopédique.

Question 3 — Le traitement de l'embarrure consiste à faire une trépanation.

A. Vrai

B. Faux

Réponse : B — Faux

Explication : Le traitement chirurgical, lorsqu’il est indiqué, consiste à relever l’enfoncement osseux. Une trépanation évacuatrice concerne notamment certains hématomes intracrâniens. Reformulation : l’embarrure peut nécessiter un relèvement neurochirurgical.

Source : INFAS, NEUROCHIRURGIE L3.pdf, p. 8–9, traitement de l’embarrure et traitement chirurgical.

Question 4 — Le mécanisme de la fracture du carpe se présente comme une chute sur la paume de la main en hyperextension, et en légère adduction.

A. Vrai

B. Faux

Réponse : B — Faux

Explication : Le cours décrit une chute sur la paume en hyperextension et légère abduction. Reformulation : le mécanisme classique associe hyperextension et légère abduction, et non adduction.

Source : INFAS, chirurgie L2 .pdf, Prise en charge infirmière des pathologies chirurgicales, 2024–2025, p. 41, fracture du carpe, mécanisme.

Question 5 — La désinfection avec un antiseptique est le premier geste dans la chronologie de soins d'une plaie.

A. Vrai

B. Faux

Réponse : B — Faux

Explication : Le cours commence par découvrir puis inspecter la plaie avant de la désinfecter. Reformulation : l’antisepsie est précédée de l’exposition et de l’évaluation de la plaie ; une hémorragie importante doit être contrôlée en priorité.

Source : INFAS, chirurgie L1 .pdf, Pathologie chirurgicale Sémiologie, 2023–2024, p. 57, conduite à tenir devant une plaie.

Question 6 — L’anthrax staphylococcique est une agglomération de furoncles.

A. Vrai

B. Faux

Réponse : A — Vrai

Explication : Plusieurs furoncles sont reliés par une suppuration du derme et du tissu sous-cutané. Il s’agit ici de l’anthrax staphylococcique.

Source : INFAS, chirurgie L1 .pdf, Pathologie chirurgicale Sémiologie, 2023–2024, p. 40, anthrax, définition.

Question 7 — L'appréciation de la gravité d'une brûlure se fait uniquement en fonction de l'étendue de la surface corporelle brûlée.

A. Vrai

B. Faux

Réponse : B — Faux

Explication : La gravité dépend également de la profondeur, de la localisation, de l’âge, du terrain et des lésions associées. Reformulation : la surface brûlée est un critère de gravité parmi plusieurs autres.

Source : INFAS, chirurgie L1 .pdf, Pathologie chirurgicale Sémiologie, 2023–2024, p. 82–86, pronostic et critères de gravité des brûlures.

Question 8 — En cas de brûlure, les fuites plasmatiques sont aussi responsables de la formation des œdèmes.

A. Vrai

B. Faux

Réponse : A — Vrai

Explication : La fuite de plasma vers le secteur interstitiel entraîne des œdèmes et peut réduire le volume sanguin circulant.

Source : INFAS, chirurgie L1 .pdf, Pathologie chirurgicale Sémiologie, 2023–2024, p. 81, brûlures, plasmorragie et formation des œdèmes.

Question 9 — Le scanner abdominal est inutile dans l'évaluation d'une contusion abdominale.

A. Vrai

B. Faux

Réponse : B — Faux

Explication : Le scanner recherche un hémopéritoine et des lésions viscérales chez un patient dont l'état permet sa réalisation. Reformulation : le scanner abdominal est utile dans l'évaluation d'une contusion abdominale.

Source : INFAS, chirurgie L2 .pdf, Prise en charge infirmière des pathologies chirurgicales, 2024–2025, p. 93, tomodensitométrie abdominale.

Question 10 — L'absence de douleur élimine une lésion thoracique grave.

A. Vrai

B. Faux

Réponse : B — Faux

Explication : Des lésions ou complications peuvent être peu symptomatiques ou se révéler secondairement. Reformulation : l'absence de douleur ne suffit pas à éliminer une lésion thoracique grave.

Source : INFAS, chirurgie L2 .pdf, Prise en charge infirmière des pathologies chirurgicales, 2024–2025, p. 8–10, examen du traumatisé thoracique et surveillance.

Question 11 — L'hémothorax correspond à une accumulation de sang dans la cavité pleurale.

A. Vrai

B. Faux

Réponse : A — Vrai

Explication : Le sang s'accumule dans l'espace pleural ; il peut diminuer le murmure vésiculaire et produire une matité à la percussion.

Source : INFAS, chirurgie L2 .pdf, Prise en charge infirmière des pathologies chirurgicales, 2024–2025, p. 9–10, traumatismes thoraciques, hémothorax.

Question 12 — Un volet thoracique améliore la mécanique respiratoire du patient.

A. Vrai

B. Faux

Réponse : B — Faux

Explication : Le volet thoracique déstabilise la paroi et peut compromettre la ventilation. Reformulation : un volet thoracique peut altérer la mécanique respiratoire.

Source : INFAS, chirurgie L2 .pdf, Prise en charge infirmière des pathologies chirurgicales, 2024–2025, p. 9–10, déformation thoracique et signes de souffrance respiratoire.

Question 13 — Tout traumatisme thoracique avec dyspnée nécessite une évaluation médicale urgente.

A. Vrai

B. Faux

Réponse : A — Vrai

Explication : La dyspnée après un traumatisme peut traduire une lésion pulmonaire ou pleurale grave et impose une évaluation urgente.

Source : INFAS, chirurgie L2 .pdf, Prise en charge infirmière des pathologies chirurgicales, 2024–2025, p. 10–12, souffrance respiratoire et traitement des traumatismes thoraciques.

Question 14 — Dans le traumatisme du thorax, à l'auscultation l'on observe une matité.

A. Vrai

B. Faux

Réponse : B — Faux

Explication : La matité est recherchée à la percussion. L’auscultation apprécie notamment le murmure vésiculaire. Reformulation : une matité thoracique peut être retrouvée à la percussion.

Source : INFAS, chirurgie L2 .pdf, Prise en charge infirmière des pathologies chirurgicales, 2024–2025, p. 9, auscultation et percussion.

Question 15 — Le pied bot varus équin n'atteint uniquement que les garçons.

A. Vrai

B. Faux

Réponse : B — Faux

Explication : Cette malformation touche les deux sexes, avec une prédominance masculine. Reformulation : le pied bot varus équin peut toucher les garçons et les filles.

Source : American Academy of Orthopaedic Surgeons, OrthoInfo, Clubfoot, rubrique Description, orthoinfo.org/diseases--conditions/clubfoot/.

Question 16 — Le pied talus se définit par une flexion plantaire excessive du pied.

A. Vrai

B. Faux

Réponse : B — Faux

Explication : Le talus correspond à une flexion dorsale excessive, le pied se rapprochant de la face antérieure de la jambe. Reformulation : le pied talus est en flexion dorsale excessive. Le valgus désigne une déviation associée vers l’extérieur.

Source : Children’s Hospital of Philadelphia, Calcaneovalgus Foot, rubriques définition et signes, chop.edu/conditions-diseases/calcaneovalgus-foot.

Question 17 — En cas de fracture crânienne, l'on observe évidemment une embarrure.

A. Vrai

B. Faux

Réponse : B — Faux

Explication : Une fracture crânienne peut être linéaire, sans enfoncement. Reformulation : l’embarrure est une forme de fracture du crâne avec enfoncement osseux, et non une conséquence systématique.

Source : INFAS, NEUROCHIRURGIE L3.pdf, p. 2–4 et 8, lésions traumatiques crâniennes et embarrure.

Question 18 — L'urètre est un conduit unilatéral qui transporte l'urine des reins vers la vessie.

A. Vrai

B. Faux

Réponse : B — Faux

Explication : Les deux uretères conduisent l’urine des reins à la vessie ; l’urètre conduit l’urine de la vessie vers l’extérieur. Reformulation : l’urètre est le conduit d’évacuation de la vessie.

Source : NIDDK, The Urinary Tract & How It Works, rubrique What is the urinary tract?, niddk.nih.gov/health-information/urologic-diseases/urinary-tract-how-it-works.

Question 19 — L'une des complications locales dans l'anthrax est l'adéno-phlegmon.

A. Vrai

B. Faux

Réponse : A — Vrai

Explication : L’adéno-phlegmon figure parmi les complications locales de l’anthrax circonscrit dans le cours.

Source : INFAS, chirurgie L1 .pdf, Pathologie chirurgicale Sémiologie, 2023–2024, p. 42, anthrax, complications locales.

Question 20 — La crépitation neigeuse est un signe physique de la gangrène gazeuse.

A. Vrai

B. Faux

Réponse : A — Vrai

Explication : Les gaz produits dans les tissus peuvent entraîner une crépitation palpable. Ce signe est évocateur mais n’est pas présent dans toutes les formes.

Source : INFAS, chirurgie L1 .pdf, Pathologie chirurgicale Sémiologie, 2023–2024, p. 45–47 et 91, gangrène gazeuse ; exercice d’application, question 9.

Étude de cas 1

Vous êtes infirmier au centre de santé rural de GROHOUNFLA. M. ZAOULI, planteur de 60 ans, arrive à 3 h du matin pour une impossibilité brutale et totale d’uriner.

Questions à choix multiples

Question 21 — À quelle pathologie pensez-vous ?

A. Rétention urinaire aiguë

B. Adénome de la prostate

C. Rétention urinaire chronique

Réponse : A

Explication : L’impossibilité brutale et totale d’uriner définit une rétention aiguë d’urine. L’adénome prostatique est une cause possible, non démontrée par ce seul énoncé.

Source : INFAS, chirurgie L2 .pdf, Prise en charge infirmière des pathologies chirurgicales, 2024–2025, p. 170, rétention aiguë, définition.

Question 22 — Un signe physique parmi ceux énumérés ci-dessous vous conforte dans votre diagnostic ; lequel ?

A. Impossibilité d'uriner

B. Besoin impérieux d'uriner

C. Un globe vésical

Réponse : C

Explication : Le globe vésical est une constatation de l’examen physique : la vessie pleine forme une masse hypogastrique.

Source : INFAS, chirurgie L2 .pdf, Prise en charge infirmière des pathologies chirurgicales, 2024–2025, p. 170–171, rétention aiguë, signes physiques.

Question 23 — Un signe fonctionnel parmi ceux indiqués ci-dessous vous rassure pour le diagnostic posé, lequel ?

A. Impossibilité d'uriner

B. Douleur sous-pubienne plus ou moins intense à la palpation

C. Globe vésical

Réponse : A

Explication : L’impossibilité d’uriner est un symptôme rapporté par le patient. La douleur déclenchée par la palpation relève ici de l’examen physique.

Source : INFAS, chirurgie L2 .pdf, Prise en charge infirmière des pathologies chirurgicales, 2024–2025, p. 170–171, signes fonctionnels et physiques.

Question 24 — Un geste d'urgence peut immédiatement soulager M. ZAOULI ; lequel ?

A. Intervention chirurgicale

B. Administration d'un antalgique

C. Sondage urétral d'urgence

Réponse : C

Explication : Le drainage vésical soulage la distension. Le sondage se réalise en asepsie, par un professionnel formé et après recherche de contre-indications ; ne pas forcer en cas d’obstacle.

Source : INFAS, chirurgie L2 .pdf, Prise en charge infirmière des pathologies chirurgicales, 2024–2025, p. 173–175, drainage vésical et interventions infirmières.

Question 25 — Parmi les situations suivantes, lesquelles ne justifient pas à elles seules un sondage urinaire à demeure ? Deux réponses.

A. Rétention aiguë d’urine

B. Douleur sus-pubienne isolée sans rétention

C. Infection urinaire sans rétention ni autre indication

D. Obstruction prostatique avec rétention d’urine

E. Incontinence réfractaire avec plaie sacrée ouverte dont la cicatrisation nécessite une dérivation urinaire

Réponse : B et C

Explication : Une douleur isolée et une infection sans rétention ne justifient pas un sondage. Le drainage doit répondre à une indication précise ; une simple incontinence ne suffit pas.

Source : EAUN, Indwelling catheterisation in adults, 2024, § 4.2 ; CDC, Summary of Recommendations, tableau 2, indications appropriées et usages inappropriés.

Question 26 — Avant et pendant la préparation d’un sondage urinaire, quelles mesures sont appropriées ? Trois réponses.

A. Hygiène des mains de l’opérateur

B. Réfection systématique du lit à la place de l’asepsie

C. Toilette génitale et nettoyage du méat avant la pose aseptique

D. Bain du praticien remplaçant l’hygiène des mains

E. Information du patient, respect de son intimité et préparation psychologique

Réponse : A, C et E

Explication : La préparation associe information du patient, hygiène des mains et préparation locale. La pose utilise une technique aseptique et du matériel stérile.

Source : EAUN, Indwelling catheterisation in adults, 2024, chapitres 6 et 10 ; CDC, Summary of Recommendations, § II, technique d’insertion.

Question 27 — L'un des objectifs visés dans la démarche de soins infirmiers, en cas de rétention urinaire est :

A. Le retour du mode d'élimination normal des urines

B. La pose de la sonde urinaire

C. La ponction sus-pubienne

Réponse : A

Explication : Le retour à une élimination urinaire normale est un objectif de soins. Le sondage et la ponction sus-pubienne sont des moyens thérapeutiques.

Source : INFAS, chirurgie L2 .pdf, Prise en charge infirmière des pathologies chirurgicales, 2024–2025, p. 175, objectifs de la démarche de soins.

Question 28 — Parmi les organes suivants, relever les deux organes qui constituent les organes de l'appareil urinaire haut :

A. Les reins

B. La vessie

C. L'urètre

D. Les uretères

E. La prostate

Réponse : A et D

Explication : Le haut appareil urinaire comprend les reins et les uretères. La vessie et l’urètre appartiennent au bas appareil.

Source : NIDDK, The Urinary Tract & How It Works, rubrique What is the urinary tract?.

Question 29 — Quels sont les deux organes du tube digestif situés entre le pharynx et le duodénum ?

A. L’estomac

B. La cavité buccale

C. L’œsophage

D. Le côlon

E. Le jéjunum

Réponse : A et C

Explication : Les aliments passent du pharynx dans l’œsophage, puis dans l’estomac, avant le duodénum.

Source : National Cancer Institute, SEER Training, Review Anatomy of the UGI Tract ; NLM MeSH, Upper Gastrointestinal Tract, D041742.

Question 30 — Quel est l’aspect habituel d’une urine fraîche chez un adulte sain correctement hydraté ?

A. Rouge et trouble

B. Jaune pâle et trouble

C. Jaune pâle et limpide

Réponse : C

Explication : Une urine habituelle est claire et jaune pâle. La teinte varie avec la concentration et l’hydratation.

Source : Cleveland Clinic, Urinalysis, rubrique Visual exam, et Urine, rubrique What color pee is healthy?.

Question 31 — Chez l'homme, l'urètre mesure environ :

A. 20 cm

B. 14 cm

C. 4 cm

Réponse : A — Environ 20 cm

Explication : L’urètre masculin mesure en moyenne environ 20 cm ; l’urètre féminin mesure environ 3 à 4 cm.

Source : National Cancer Institute, Urethral Cancer Treatment PDQ, rubrique Anatomy ; SEER Training, Urethra.

Question 32 — L'anurie se caractérise par :

A. Une production urinaire supérieure à 3 L par jour

B. Une diminution modérée de la production urinaire

C. Une production urinaire nulle ou quasi nulle, inférieure à 100 mL par 24 heures chez l’adulte

Réponse : C

Explication : L’anurie est une absence ou quasi-absence de production urinaire. Elle doit être distinguée d’une rétention avec vessie pleine.

Source : University of California San Francisco, Hospital Handbook, 10 Low Urine Output, rubrique Definition.

Question 33 — Quelle valeur correspond à la diurèse moyenne usuelle sur 24 heures chez un adulte sain ?

A. 1 500 mL

B. 100 mL

C. 300 mL

Réponse : A — 1 500 mL

Explication : La production habituelle est de l’ordre de 1 à 2 litres par jour. Elle varie avec les apports, les pertes et le contexte clinique.

Source : NIDDK, The Urinary Tract & How It Works, rubrique Kidneys.

Question 34 — La rétention urinaire chronique est dite rétention avec distension lorsque le volume du résidu post-mictionnel est :

A. Supérieur à 300 ml

B. Inférieur à 300 ml

C. Égal à 300 ml

Réponse : A

Explication : Dans la classification enseignée, le résidu post-mictionnel supérieur à 300 mL correspond à une rétention chronique avec distension.

Source : INFAS, chirurgie L2 .pdf, Prise en charge infirmière des pathologies chirurgicales, 2024–2025, p. 171, rétention chronique, définition.

Question 35 — Parmi les signes suivants, relever le signe fonctionnel de la rétention chronique d'urine :

A. Impossibilité d'uriner

B. besoin impérieux d'uriner permanent devenant douloureux et n'aboutissant au mieux qu'à l'émission de quelques gouttes d'urines

C. Impossibilité de vider totalement la vessie

Réponse : C

Explication : La vidange vésicale est incomplète ; des mictions restent possibles. L’impossibilité brutale et totale caractérise la forme aiguë.

Source : INFAS, chirurgie L2 .pdf, Prise en charge infirmière des pathologies chirurgicales, 2024–2025, p. 170–172, rétention aiguë et chronique.

Question 36 — Quels sont les trois examens biologiques proposés dans le cours pour explorer un adénome prostatique et son retentissement ?

A. Test de grossesse

B. Urée et créatinine

C. Goutte épaisse

D. PSA, selon le contexte et après information du patient

E. ECBU

Réponse : B, D et E

Explication : Le bilan rénal recherche un retentissement, l’ECBU une infection et le PSA un éventuel cancer associé selon le contexte. Le PSA ne diagnostique pas à lui seul une HBP.

Source : INFAS, chirurgie L2 .pdf, Prise en charge infirmière des pathologies chirurgicales, 2024–2025, p. 163, examens complémentaires biologiques. Complément : Collège français d’urologie, référentiel 6e édition, chapitre 10, § V.

Question 37 — Parmi les signes suivants, relever les deux signes physiques de la rétention aiguë d'urine :

A. Douleur sus-pubienne de plus en plus intense

B. Douleur à la palpation augmentant le besoin d'uriner

C. Impossibilité d'uriner

D. Masse hypogastrique pouvant remonter jusqu'à l'ombilic

E. Globe vésical flaccide parfois énorme de 2 à 3 litres et indolore

Réponse : B et D

Explication : La masse hypogastrique et la douleur provoquée à la palpation sont des signes physiques. Le globe volumineux, flaccide et indolore décrit en E correspond plutôt à la rétention chronique.

Source : INFAS, chirurgie L2 .pdf, Prise en charge infirmière des pathologies chirurgicales, 2024–2025, p. 170–172, signes physiques des rétentions.

Étude de cas 2

Vous recevez Mademoiselle Daména, âgée de 27 ans, pesant 90 kg, victime d’un accident avec collision de deux véhicules. L’examen ne retrouve pas de lésion corporelle externe. Elle présente une douleur abdominale, une tachypnée superficielle, une tension artérielle basse, une soif intense, des sueurs froides profuses et un bombement du cul-de-sac de Douglas au toucher rectal. Le chirurgien pose le diagnostic de contusion abdominale.

Question 38 — Quelle définition accordez-vous à la contusion abdominale ?

A. Traumatismes de l'abdomen avec mise en évidence des viscères

B. Traumatismes de l'abdomen sans solution de continuité

C. Traumatisme de l'abdomen avec solution de continuité profonde

D. Traumatismes de l'abdomen avec lésion costale

Réponse : B

Explication : La contusion est un traumatisme fermé : la paroi ne présente pas de solution de continuité, même si les viscères sont lésés.

Source : INFAS, chirurgie L2 .pdf, Prise en charge infirmière des pathologies chirurgicales, 2024–2025, p. 89, contusion abdominale, définition.

Question 39 — Les signes observés chez dame Daména, vous font évoquer quel tableau ?

A. Tableau d'hémopéritoine.

B. Tableau de péritonite par perforation d'organe creux.

C. Tableau d'abdomen contus apparemment normal

Réponse : A

Explication : L’hypotension, la soif, les sueurs froides et le signe pelvien font suspecter une hémorragie intrapéritonéale avec choc hypovolémique.

Source : INFAS, chirurgie L2 .pdf, Prise en charge infirmière des pathologies chirurgicales, 2024–2025, p. 90–91, tableau d’hémopéritoine.

Question 40 — Quels sont les trois signes compatibles avec un état de choc chez Daména ?

A. Une douleur abdominale

B. Une soif intense

C. Une tachypnée

D. Des sueurs froides profuses

E. Un bombement du cul-de-sac de Douglas

Réponse : B, C et D

Explication : La soif intense, les sueurs froides et la tachypnée sont compatibles avec le choc, dans ce contexte d’hypotension et d’hémorragie suspectée. Le cours classe aussi la tachypnée parmi les signes d’anémie aiguë.

Source : INFAS, chirurgie L2 .pdf, Prise en charge infirmière des pathologies chirurgicales, 2024–2025, p. 91, signes d’anémie aiguë et de choc hypovolémique.

Question 41 — Le chirurgien suspecte la rupture de viscères pleins, lesquels ?

A. Duodénum

B. Foie

C. Jéjunum

D. Iléon

E. Rate

F. Estomac

Réponse : B et E

Explication : Le foie et la rate sont des viscères pleins. Les autres propositions correspondent à des organes creux.

Source : INFAS, chirurgie L2 .pdf, Prise en charge infirmière des pathologies chirurgicales, 2024–2025, p. 90, lésions viscérales.

Question 42 — Quel signe clinique présenté par Daména évoque particulièrement un épanchement liquidien intrapéritonéal ?

A. Une douleur abdominale

B. Une tension artérielle basse

C. Un bombement du cul-de-sac de Douglas au toucher rectal

D. Une tachypnée superficielle

Réponse : C

Explication : Le bombement du cul-de-sac de Douglas est un signe clinique évocateur d'un épanchement pelvien. Il ne confirme pas à lui seul sa nature ; l'imagerie complète l'évaluation.

Source : INFAS, chirurgie L2 .pdf, Prise en charge infirmière des pathologies chirurgicales, 2024–2025, p. 91–93, épanchement intrapéritonéal et imagerie.

Question 43 — À l'examen physique de Daména, la palpation recherche les deux signes suivants. Lesquels ?

A. Recherche des lésions cutanées

B. Une défense localisée

C. Une matité déclive des flancs

D. Un tympanisme diffus ou localisé

E. Des points douloureux exquis

Réponse : B et E

Explication : La palpation recherche les points douloureux et la défense. La matité et le tympanisme se recherchent à la percussion ; les lésions cutanées à l'inspection.

Source : INFAS, chirurgie L2 .pdf, Prise en charge infirmière des pathologies chirurgicales, 2024–2025, p. 92, examen physique abdominal.

Question 44 — Le bilan biologique de Daména comporte les deux examens suivants :

A. Bilan de l'hémostase

B. Acide urique isolé

C. Doppler pulsé

D. Ionogramme sanguin

E. Électroencéphalogramme

Réponse : A et D

Explication : Le bilan de l'hémostase recherche un trouble de la coagulation ; l'ionogramme évalue les principaux électrolytes sanguins. Ils font partie du bilan biologique décrit dans le cours.

Source : INFAS, chirurgie L2 .pdf, Prise en charge infirmière des pathologies chirurgicales, 2024–2025, p. 92–93, examens biologiques.

Question 45 — La conduite à tenir dans le traitement de Daména a deux buts :

A. Prendre une voie veineuse sûre de préférence au cathéter

B. Compenser la perte sanguine

C. Mettre une sonde urinaire

D. Réaliser l'hémostase de la région atteinte

E. Mise en place d'une sonde naso-gastrique

Réponse : B et D

Explication : Les buts sont de restaurer la circulation en compensant les pertes et d’arrêter le saignement. Les voies veineuses et les sondes sont des moyens.

Source : INFAS, chirurgie L2 .pdf, Prise en charge infirmière des pathologies chirurgicales, 2024–2025, p. 95, buts du traitement des lésions internes graves.

Brûlures

Question 46 — Une brûlure du 2e degré atteint :

A. Seulement l'épiderme

B. L'épiderme et une partie du derme

C. Le muscle uniquement

D. L'os

E. L'épiderme, le derme et l'hypoderme

Réponse : B

Explication : La lésion détruit l’épiderme et atteint une partie du derme. La profondeur de l’atteinte dermique distingue le deuxième degré superficiel du profond.

Source : INFAS, chirurgie L1 .pdf, Pathologie chirurgicale Sémiologie, 2023–2024, p. 86, profondeur des brûlures.

Question 47 — Quel signe est caractéristique d’une brûlure du deuxième degré superficiel ?

A. Peau intacte

B. Escarre noire indolore

C. Phlyctènes (cloques)

D. Absence de rougeur

E. Anesthésie complète de la zone brûlée

Réponse : C

Explication : Les phlyctènes sont typiques du deuxième degré, surtout superficiel. Une escarre insensible évoque une brûlure plus profonde.

Source : INFAS, chirurgie L1 .pdf, Pathologie chirurgicale Sémiologie, 2023–2024, p. 86, deuxième degré superficiel.

Question 48 — Quels sont les deux éléments qui participent à l’évaluation de la gravité d’une brûlure ?

A. La couleur des cheveux du patient

B. Le groupe sanguin

C. La surface corporelle brûlée

D. La pointure des chaussures

E. La zone atteinte

Réponse : C et E

Explication : L’étendue et la localisation sont deux critères de gravité. Il faut aussi considérer la profondeur, l’âge, le terrain et les lésions associées.

Source : INFAS, chirurgie L1 .pdf, Pathologie chirurgicale Sémiologie, 2023–2024, p. 84–86, critères de gravité.

Question 49 — Une brûlure du 2e degré superficiel cicatrise généralement en :

A. 1 à 3 jours

B. 10 à 21 jours

C. Plus de 6 mois

D. Jamais spontanément

E. 4 semaines

Réponse : B

Explication : Une brûlure superficielle du deuxième degré cicatrise généralement spontanément en une à trois semaines environ, si elle ne se complique pas. Le cours indique environ dix jours.

Source : INFAS, chirurgie L1 .pdf, Pathologie chirurgicale Sémiologie, 2023–2024, p. 86, deuxième degré superficiel.

Question 50 — Une brûlure du 2e degré étendue chez un enfant doit conduire à :

A. Une simple surveillance à domicile dans tous les cas

B. Une évaluation médicale rapide

C. Aucun soin particulier

D. Une exposition au soleil pour sécher la plaie

E. Badigeonner la plaie avec du mercurochrome

Réponse : B

Explication : Une brûlure étendue expose à une perte liquidienne, à l’hypothermie et à l’infection. L’enfant nécessite une évaluation rapide et une orientation adaptée.

Source : INFAS, chirurgie L1 .pdf, Pathologie chirurgicale Sémiologie, 2023–2024, p. 81–86, physiopathologie et gravité.

Question 51 — Quelle complication est fréquente en cas de brûlure du 2e degré ?

A. Myopie

B. Infection

C. Hypertension artérielle

D. Otite

E. Fièvre

Réponse : B

Explication : La perte de la barrière cutanée favorise l’infection. Une fièvre est un signe clinique possible, et non ici le nom de la complication recherchée.

Source : INFAS, chirurgie L1 .pdf, Pathologie chirurgicale Sémiologie, 2023–2024, p. 83, complications infectieuses.

Question 52 — Lors des premiers secours, quelle conduite adopter face à des cloques intactes ? Une réponse.

A. Les percer systématiquement

B. Les arracher

C. Les protéger avec un recouvrement propre non adhérent, sans les percer soi-même

D. Les frotter avec de l’alcool

E. Comprimer fortement la zone brûlée

Réponse : C

Explication : La protection limite les traumatismes et la contamination. Un éventuel traitement des phlyctènes par un soignant dépend de leur aspect et du protocole.

Source : Croix-Rouge française, Que faire en cas de brûlure ?, gestes de premiers secours, croix-rouge.fr/les-gestes-de-premiers-secours/que-faire-en-cas-de-brulure.

Question 53 — Quel geste chirurgical peut être nécessaire dans une brûlure du deuxième degré profond ? Une réponse.

A. Aucun traitement ne peut jamais être nécessaire

B. Une chirurgie cardiaque

C. Une greffe cutanée

D. Une amputation systématique

E. Une trépanation

Réponse : C

Explication : Une brûlure du deuxième degré profond peut nécessiter une greffe selon sa profondeur et son évolution. Une cicatrisation spontanée reste possible dans certains cas, mais elle est plus lente et peut laisser une cicatrice.

Source : INFAS, chirurgie L1 .pdf, Pathologie chirurgicale Sémiologie, 2023–2024, p. 86 et 88, profondeur et traitement local.

Question 54 — Après suppression de la source de chaleur et sécurisation de la victime, quel est le premier geste local recommandé pour une brûlure thermique récente ?

A. Appliquer du beurre

B. Percer les cloques

C. Refroidir avec de l'eau tempérée

D. Mettre de la glace directement sur la brûlure

E. L’exposer au vent

Réponse : C

Explication : Refroidir précocement la zone avec de l’eau tempérée, idéalement environ vingt minutes, sans glace. Prévenir l’hypothermie, notamment chez l’enfant ou en cas de brûlure étendue.

Source : Assurance Maladie, Brûlures de la peau, rubriques Refroidir la zone brûlée et Éviter certains gestes nocifs, ameli.fr/assure/sante/urgence/accidents-domestiques/brulures-peau.

Question 55 — La douleur d’une brûlure du deuxième degré superficiel est généralement :

A. Présente uniquement dans les brûlures profondes

B. Toujours absente pendant les premières 24 heures

C. Très intense

D. Absente

E. Toujours faible

Réponse : C

Explication : Le deuxième degré superficiel est très douloureux. Les brûlures profondes peuvent être moins sensibles lorsque les terminaisons nerveuses sont détruites.

Source : INFAS, chirurgie L1 .pdf, Pathologie chirurgicale Sémiologie, 2023–2024, p. 86, profondeur. Assurance Maladie, Brûlures de la peau, rubrique Deuxième degré superficiel.

Références complémentaires en ligne

Taslakian et al., appendicite gauche et malrotation
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/23761499/

EAUN, sondage à demeure chez l'adulte, 2024
https://nurses.uroweb.org/guidelines/indwelling-catheterisation-in-adults-urethral-and-suprapubic

CDC, prévention des infections sur sonde
https://www.cdc.gov/infection-control/hcp/cauti/summary-of-recommendations.html

Collège français d'urologie, HBP, 6e édition
https://www.urofrance.org/lafu-academie/formation-du-college/referentiel-du-college-durologie-6eme-edition/chapitre-10-item-127-hypertrophie-benigne-de-la-prostate/

AAOS, Clubfoot
https://www.orthoinfo.org/diseases--conditions/clubfoot/

CHOP, Calcaneovalgus Foot
https://www.chop.edu/conditions-diseases/calcaneovalgus-foot

NIDDK, voies urinaires
https://www.niddk.nih.gov/health-information/urologic-diseases/urinary-tract-how-it-works

NCI, anatomie de l'urètre
https://www.training.seer.cancer.gov/anatomy/urinary/components/urethra.html

NLM, tube digestif haut
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/mesh/68041742

Cleveland Clinic, examen d'urine
https://my.clevelandclinic.org/health/diagnostics/17893-urinalysis

UCSF, diurèse basse et anurie
https://hospitalhandbook.ucsf.edu/10-low-urine-output/10-low-urine-output

Assurance Maladie, brûlures
https://www.ameli.fr/assure/sante/urgence/accidents-domestiques/brulures-peau

Croix-Rouge française, premiers secours pour brûlure
https://www.croix-rouge.fr/les-gestes-de-premiers-secours/que-faire-en-cas-de-brulure